

Restrukturyzacja *interpretacji cielesnych*

Zamiana „umieram” na „adrenalina”. Dziennik 5-kolumnowy — rdzeń CBT Clarka dla paniki.

CZAS: 15–20 min na zapis 3–5× w tygodniu, 2–4 tyg.

ŹRÓDŁO: Clark & Salkovskis (1991); McNally (1994); Clark i wsp. (1999)

JAK UŻYWAĆ

Po każdym ataku — lub gdy zauważasz katastroficzną myśl — wypełnij wiersz dziennika 5-kolumnowego: **(1) odczucie, (2) pierwsza myśl + wiara 0-100%, (3) dowody za, (4) dowody przeciw, (5) realistyczna interpretacja + nowa wiara**. Wracaj do zapisów co tydzień — z czasem zauważysz spadek wiary w katastrofę.

DLACZEGO TO DZIAŁA

McNally (1994) pokazał, że **tendencyjność interpretacyjna** (ang. *interpretation bias*) u osób z zaburzeniem panicznym działa *automatycznie* — odczucie aktywuje katastrofę w milisekundach, zanim zdążysz pomyśleć. Dlatego sama wola „nie myśl tak” nie działa. Dziennik wymusza powolne, świadome przepracowanie dowodów — zostawia ślad, który następnym razem aktywuje się równoległe z katastrofą i z czasem ją wypiera.

01 Pięć kolumn dziennika — co i jak wpisać

1 · ODCZUCIE CIELESNE

Konkret, bez interpretacji. „Szybkie bicie serca, około 120/min, przez 5 min”, nie „dziwnie się czułem/-am”.

2 · PIERWSZA MYŚL + WIARA

Dosłowna myśl + **wiara 0-100%**. „Dostaję zawału — wiara 85%”. Cytat, nie opis.

3 · DOWODY ZA

Szczerze, ale z zasadą „*uczucie ≠ dowód*”. Sam fakt, że tak czujesz, nie liczy się. Tylko fakty obserwowalne.

4 · DOWODY PRZECIW

Cztery typy: **historia** („miałem/-am to 100 razy”), **medyczne** („EKG OK”), **fizjologia** („kawa daje to samo”), **różnicowe** („zawał ma inny obraz”).

5 · REALISTYCZNA INTERPRETACJA + NOWA WIARA W KATASTROFĘ

Konkretna, oparta na dowodach. „*To reakcja stresowa. Adrenalina. Minie w 20 min. Zdarzało się już dziesiątki razy.*” + ponowna ocena wiary w pierwotną katastrofę (0-100%). Z czasem wiara w katastrofę spada, w alternatywę — rośnie.

02 Cztery typy dowodów PRZECIW — żaden nie wystarczy sam

TYP DOWODU	PYTANIE DO SIEBIE	PRZYKŁAD ODPOWIEDZI
Historia	Ile razy już miałem/-am to odczucie? Co się stało wtedy?	„Miałam to 100 razy — nigdy nie był zawał.”
Medyczne	Co pokazały badania? Czy lekarz wykluczył podłoże?	„Kardiolog potwierdził zdrowe serce, EKG OK, TSH norma.”
Fizjologia	Co jeszcze daje takie same objawy — i jest niegroźne?	„Kawa i wysiłek też dają szybkie serce. To adrenalina.”
Różnicowe	Czym RÓŻNI się rzeczywista katastrofa od mojego objawu?	„Zawał = ból promieniujący + duszność wysiłkowa, nie nagły lęk.”

03 Mój zapis — krok po kroku

Wybierz **jedną** katastroficzną myśl z dziennika ataków lub z ostatniego ataku. Przejdź przez 5 kolumn powoli — nie pomijaj żadnej.

1 • ODCZUCIE CIELESNE

— konkret, bez interpretacji

2 • PIERWSZA MYŚL + WIARA (0–100%)

— dosłowna myśl

3 • DOWODY ZA

— fakty obserwowalne, „uczucie ≠ dowód”

4 • DOWODY PRZECIW

— historia + medyczne + fizjologia + różnicowe

5 • REALISTYCZNA INTERPRETACJA + NOWA WIARA (0–100%)

— konkretna, oparta na dowodach

=== Skala PRZED/PO ===

PRZED Zaznacz wiarę w katastrofę **PRZED** wypełnieniem dziennika.

Wiara w katastrofę 0% — nie wierzę 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100% — pewne

PO PO wypełnieniu wszystkich 5 kolumn — zaznacz ponownie.

Wiara w katastrofę 0% — nie wierzę 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100% — pewne

Klucz: sama restrukturyzacja werbalna ma ograniczoną moc. Clark i wsp. (1999) pokazali, że **największy efekt** uzyskuje się przy połączeniu z *ekspozycją interoceptywną*. Trzeba „uwierzyć ciałem, nie tylko głową” — stąd sekwencja: najpierw dziennik (powolne przepracowanie), potem eksperyment behawioralny (sprawdzenie w praktyce).